

ENDOCARDITIS AGUDA

Samuel Del Castillo García, Laura Álvarez Roy, Carlos Minguito Carazo, Guisela María Flores Vergara, Miguel Rodríguez Santamarta, Tomás Benito González, Carlota Hernández Díaz, Silvia Prieto González, Carmen Echevárren Palacios.

INTRODUCCIÓN

La endocarditis infecciosa (EI) se debe a la invasión del endocardio por microorganismos; hablamos de endocarditis aguda cuando las manifestaciones aparecen en días o incluso horas (suelen ser gérmenes muy virulentos como S. Aureus o S. Pyogenes).

DIAGNÓSTICO

Entre las manifestaciones clínicas se encuentran la fiebre (síntoma hasta en el 90% de los pacientes), escalofríos, síntomas constitucionales (anorexia, astenia), artralgia, mialgias. En cuanto a las manifestaciones cardiacas derivadas de la destrucción valvular podemos encontrarnos disnea, dolor torácico, soplo cardíaco. Hasta en un 25% de los pacientes podemos encontrar fenómenos embólicos en el momento del diagnóstico (cerebrales, esplénicas, renales, cutáneas, entre otros)

Pruebas complementarias

- Hemograma con fórmula leucocitaria y VSG.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, amilasa, PCR, Procalcitonina, ácido láctico, CK, CKmb, troponina ultrasensible, Pro-BNP.
- Coagulación básica, con D-Dímero.
- Hemocultivos (al menos 2) si fiebre o sospecha.
- Ecocardiograma
- Otros: TAC, RMN cardíaca.

Podremos encontrar leucocitosis con neutrofilia, elevación de los reactantes de fase aguda (PCR, VSG, procalcitonina), así como lesión de órganos diana (elevación de ácido láctico, hipertransaminasemia, disfunción renal)

Entre los métodos diagnósticos, además de la clínica y los hallazgos analíticos es fundamental la ecocardiografía como prueba de imagen, tanto la transtorácica como el ecocardiograma transesofágico (cuando esté indicado por parte del cardiólogo), otros métodos diagnósticos como la RMN, TAC u otras técnicas de medicina nuclear pueden ser de gran utilidad.

Actualmente los criterios diagnósticos aceptados para el diagnóstico de la EI son los **criterios modificados de Duke**, que aúnan criterios clínicos, microbiológicos y de imagen.

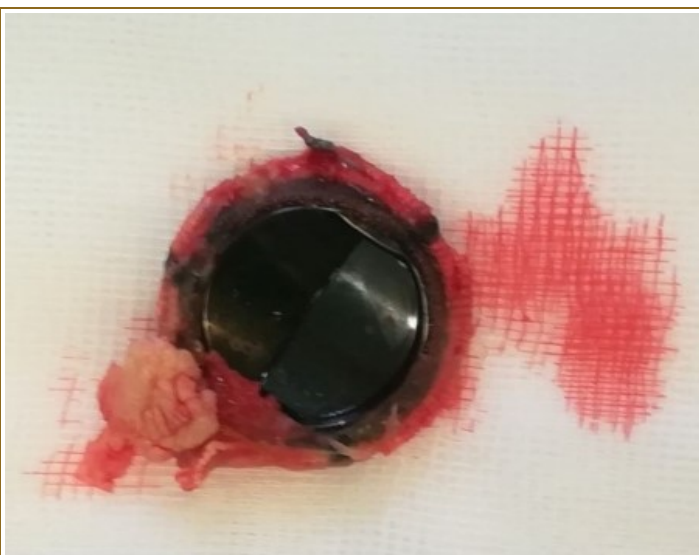
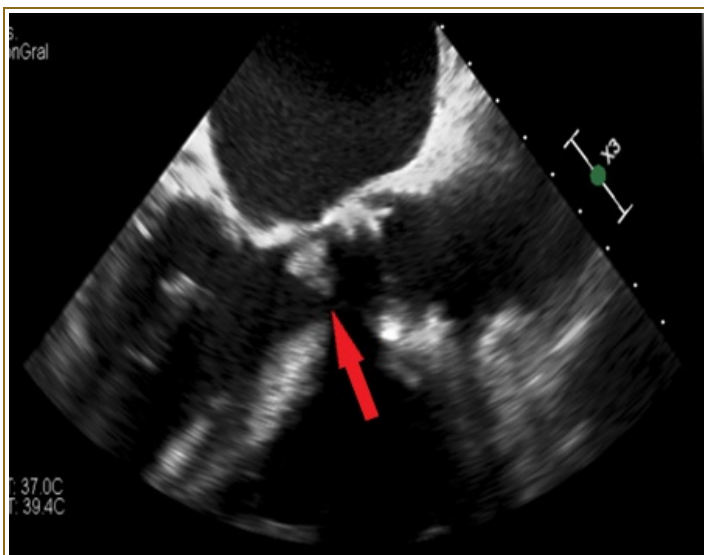


Imagen izquierda: ecocardiograma transesofágico Flecha roja: verruga endocárdica sobre válvula protésica aórtica. Imagen derecha: pieza anatómica

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

- En urgencias lo más importante es sospecharlo ante un paciente con factores predisponentes (válvulas protésicas, dispositivos intracardiacos, valvulopatías...), presencia de fiebre o soplo de nueva aparición.
- El tratamiento médico en urgencias de una endocarditis infecciosa aguda consistirá en soporte hemodinámico si el paciente lo precisa, el tratamiento propio de la insuficiencia cardíaca (diuréticos, oxigenoterapia, vasodilatadores...) así como un adecuado y temprano tratamiento antibiótico (siempre tras la extracción de hemocultivos)
- Tratamiento antibiótico empírico según cuadro.
- Interconsulta a cardiología.

Tratamiento antibiótico empírico de EI sobre Válvula nativa o protésica tardía (>12 meses tras cirugía)	Tratamiento antibiótico empírico de EI sobre Válvula protésica precoz (<12 meses tras cirugía)
Ampicilina (12g/24h) + Cloxacilina (12g/24h) + Gentamicina (3mg/Kg/24h)	en Vancomicina (30mg/Kg/24h) + Gentamicina (3mg/Kg/24h) + Rifampicina (900-1200mg/24h)
Vancomicina (30-60 mg/Kg/24h) + Gentamicina (3mg/Kg/24h)	-

Tratamiento antibiótico empírico de la EI según las guías actuales

BIBLIOGRAFÍA

- Habib G, Lancellotti P, Antunes MJ, Bongiorni MG, Casalta JP et al. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis. The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2015; 36(44):3075–3123.
- López Fernández T, Rosillo Rodríguez S, Gemma D. Valvulopatías. Lesiones de las válvulas nativas y de las prótesis valvulares. En: Nuñez-Gil I, Viana-Tejedor A. Cardio Agudos. 1ª ed. 2015. Madrid: CTO editorial; 2015. p. 225- 237.